

AFMCP Chapter 1 — 한국어 전문 번역

기능의학 임상 적용 (Applying Functional Medicine in Clinical Practice)

IFM AFMCP 과정 | 한국어 번역본

강의 1: 기능의학 입문 (Dr. Kelechi Uduhiri)

안녕하세요, Applying Functional Medicine in Clinical Practice에 오신 것을 환영합니다. 저는 진행자 Dr. Kelechi Uduhiri입니다. 오늘 이 모듈에서 여러분이 배울 내용에 대한 간략한 소개를 드립니다. 공개할 재정적 이해관계는 없으며, 이것은 우리 입문 과정의 매우 간략한 개요임을 기억해 주시기 바랍니다.

만성 염증의 선행요인, 촉발요인, 매개요인(ATMs), 특히 식이, 생활방식, 장(gut)에 대한 임상 지표 강조가 강화됩니다. 면역 반응의 메커니즘과 구성요소에 대한 강조는 줄어들고, 대신 염증을 완화할 수 있는 음식 우선(food first), 생활방식, 장 중재에 대한 강조가 강화됩니다.

이것이 바로 임상 방법론이며, 여러분은 기능의학 임상 실습에서 이 프레임워크를 사용하게 될 것입니다. 간략히 말하면, 이것을 GOTOIT이라고 합니다. 정보를 수집(Gather)하고, 그 정보를 정리(Organize)하고, 치료적 관계를 구축하기 위해 이야기를 환자에게 다시 전달(Tell)합니다. 어떤 것이 먼저 올 것인지 순서를 정하고(Order), 치료 계획을 시작(Initiate)하고, 중재의 진행 상황을 추적(Track)합니다. 이것이 기능의학에서 사용하는 일반적인 프레임워크입니다.

기초 치료 접근법은 무엇인가요? 생활방식 우선, 그 다음 음식 우선입니다. 저는 이것을 '의약품으로서의 음식(food as medicine)'이라고 부릅니다. 환자를 phyto 플랜이나 코어 플랜으로 시작할 수 있다는 것을 이해하는 것입니다. 음식 우선 다음에는 장(gut) 우선, 그 다음에는 매트릭스가 있습니다. 매트릭스는 환자와 함께 수집한 정보를 정리하는 또 다른 수준입니다. 이것은 조사를 통해 보고 있을 수 있는 임상적 불균형과 생리적 기능 장애를 살펴보는 방법입니다.

왼쪽 패널에는 환자의 이야기가 있습니다. 이야기에는 유전된 것, 후천적으로 획득한 것이 포함됩니다. 이것을 선행요인(antecedents)이라고 합니다. 그런 다음 질병 과정을 시작하게 하는 촉발요인(triggers)과 사건들이 있습니다. 그리고 상황을 지속시키는 매개요인(mediators)이 있습니다. 기능의학 매트릭스의 하단에는 수정 가능한 생활방식 요인들이 있습니다: 수면, 신체 활동, 영양, 스트레스 요인, 관계.

매트릭스의 각 노드를 살펴봅시다: 동화(Assimilation)에서는 5R 접근법을 배웁니다. 만성 염증은 방어 및 수복(Defense and Repair) 노드에 해당합니다. 커뮤니케이션(Communication) 노드에서는 만성 스트레스와 부신 조절 장애가 신체 시스템 간 소통에 어떤 영향을 미치는지 살펴봅시다. 수송(Transport) 노드에서는 고혈압, 심장 질환, 당뇨병 같은 심장대사 기능 장애를 봅니다. 독소의 완화 및 제거도 매우 중요합니다. 에너지(Energy) 노드에서는 미토콘드리아 기능 장애를 살펴봅시다.

구조적 무결성(Structural Integrity) — 근육, 관절, 힘줄, 연골 — 이 모든 것이 환자의 삶의 경험에 어떤 영향을 미치는지 살펴봅시다. 이 매트릭스의 중심에는 물론 정신적, 감정적, 영적 측면이 있습니다. 우리는 이것을 제쳐둘 수 없습니다. 이것이 환자가 좋은 삶의 경험을 하느냐, 매우 나쁜 삶의 경험을 하느냐를 결정하는 부분입니다.

Applying Functional Medicine in Clinical Practice에 오신 것을 환영합니다. 이 모듈에서 정말 즐거운 시간을 보내실 것입니다. 언제든지 임상 포럼에 참여하여 교육자들과 IFM 진행자들에게 질문하시기 바랍니다.

강의 2: 기능의학의 원칙과 개념 (Dr. Robert Luby & Monique Class)

안녕하세요, 기능의학의 원칙과 개념 소개에 오신 것을 환영합니다. 저는 기능의학 연구소(IFM)의 의학 교육 이사 Robert Luby입니다. 그리고 저는 인증 가정 전문 간호사이자 IFM의 수석 교수진 중 한 명인 Monique Class입니다.

기능학을 설명하는 것은 설명만으로 의학적 패러다임을 이해하기 어렵습니다. 실천하는 의사가 무엇을 하고 있는지 설명하는 것이 더 효과적입니다. 기능의학은 시스템 기반 접근법이자 패러다임입니다. 포괄적이며 질병만을 다루는 것이 아니라 환자의 건강, 생리적 기능, 웰빙을 다룹니다. 이것은 기존 의학의 중요한 파트너가 되도록 설계되었으며, 특히 만성 복합 질환 분야에서 우리가 원하는 결과를 얻지 못하는 영역에서 더 나은 결과를 달성할 수 있습니다.

기능의학은 질병을 다루는 것 외에도 근본 원인을 다룹니다. 이를 위해 환자의 유전적, 환경적, 생활방식 영향을 이해해야 합니다. 기존 훈련을 대체하는 것이 아니라 추가적이고 상호보완적입니다. 임상 접근법은 증상과 질병뿐만 아니라 생리적 기능 장애도 식별합니다.

기능학을 실천할 때 의사는 무엇을 하고 있는가? 수집(Gathering)이 핵심 단계입니다. 환자방에 들어가기 전에 자신을 준비하는 것과 환자에 대한 더 깊은 이해를 얻기 위한 정보 수집이 포함됩니다. 무엇이 중요한지, 그들의 목표, 우선순위, 선호도가 무엇인지 이해하기 위한 정보를 수집합니다. 단순히 증상 검토를 넘어서, 증상을 경험하는 데 기여하는 삶의 주요 건강 요인들을 파악합니다.

우리는 선행요인(antecedents)을 살펴봅니다. 이것은 누군가를 복잡한 만성 질환으로 이어지게 하는 유전자, 경향성, 소인입니다. 촉발요인(triggers)은 무엇인가? 마지막으로 건강했던 때가 언제였나? 그 이후로 한 번도 건강하지 않았다면, 그것이 촉발요인입니다. 그리고 상황을 지속시키는 매개요인(mediators)은 무엇인가? 불면증인가? 스트레스인가? 먹는 음식인가? 움직임의 부족인가?

우리는 환자의 모든 정보를 타임라인을 통해 살펴봄으로써 시스템 전반에 걸친 생리적 기능 장애 패턴을 볼 수 있습니다. 그런 다음 그 모든 데이터를 매트릭스라고 불리는 것에 정리합니다. 매트릭스는 7개 시스템의 불균형에 대한 근본 원인이 될 수 있는 선행요인, 매개요인, 촉발요인, 생활방식 요인을 식별할 수 있는 하나의 공간입니다.

기능의학은 치료적 파트너십을 우선시합니다. 우리는 누군가에게 무언가를 하는 것에서 누군가와 함께 무언가를 하는 것으로 이동합니다. 환자들은 자신의 치료에 적극적으로 참여하게 됩니다. '지금 이 순간 심리적으로, 재정적으로, 감정적으로 가능한 것은 무엇인가요? 첫 번째 단계는 무엇인가요?'라고 물어봅니다.

기능의학은 안전하고 유효하며 효과적인 중재로 시작합니다. 처방을 사용하지만 식이 및 생활방식 변화가 효과를 발휘하는 데 걸리는 시간 동안의 가교 치료로 사용합니다. 음식 우선, 생활방식 우선 패러다임 전환으로 식이, 수면, 운동, 명상, 사회적 연결을 우선시합니다.

기능의학이 해결하려는 문제는 무엇인가? 기능의학은 전 세계적인 만성 질환 유행에 대응합니다. 의료비의 90%가 복잡한 만성 질환과 정신 건강 상태에 사용됩니다. 우리는 급성 감염 기반 임상의로 훈련받았지만, 현재 환경에서는 복잡한 만성 질환이 주요 과제입니다.

연구 결과, Cleveland Clinic에서의 연구에서 기능의학 접근법으로 3개월 이내에 환자당 500달러 이상의 비용 절감이 있었습니다. 특정 질환에 대해 당뇨병, 인지 저하, 염증성 관절염, 염증성 장 질환, 다발성 경화증 등 많은 고비용, 고빈도 만성 질환을 개선할 수 있다는 연구들이 발표되어 있습니다.

기능의학은 21세기를 위한 좋은 의학입니다. 19세기와 20세기에는 기관 기반 접근법이 매우 효과적이었습니다. 21세기에 더 나은 결과를 얻기 위해 기능의학은 다계통 기반 장애에 대한 시스템 기반 접근법을 제공합니다. 근본 원인 의학으로 증상만 식별하는 것이 아니라 증상의 근본 원인을 식별하고, 질병만 진단하는 것이 아니라 기능 장애를 진단합니다.